



Sujet 75 : Vaccinations ; N° Validation : 0206202575

Faculté de médecine de Sousse
Cycle de préparation au concours de résidanat
Pr BOUGHAMOURA Lamia
P.Ag TEJ Amel
Août 2025

Sujet 75 : Vaccinations

Objectif 1. Décrire les bases immunologiques de la réponse post vaccinale induite.

1. L'adjuvant :

- A. Est présent dans les vaccins vivants atténués
- B. Permet d'améliorer la réponse immunitaire
- C. Favorise la réaction inflammatoire locale
- D. Assure une immunité plus durable
- E. Permet de majorer la quantité d'antigène utilisée

2. L'adjuvant est présent dans le(s) vaccin(s) suivant(s) :

- A. Le BCG
- B. Le vaccin anti hépatite B
- C. Le vaccin anti rougeole
- D. Le Vaccin anti rubéole
- E. Le vaccin anti Polio oral

Objectif 2. Décrire les différents types de vaccins.

3. Les vaccins inactivés (tués) :

- A. Contiennent un pathogène inactivé par la chaleur
- B. Exposent au risque infectieux
- C. Nécessitent une seule injection
- D. Induisent préférentiellement une réponse humorale
- E. Sont moins efficaces dans l'induction d'une immunité cellulaire

4. Pour les vaccins sous-unitaires :

- A. L'immunogénicité est plus faible que celle des vaccins vivants
- B. Une primo vaccination faite de 2 à 3 injections à 15 jours d'intervalle est nécessaire
- C. Des rappels permettent d'assurer une bonne protection
- D. L'adjonction d'un adjuvant est souvent nécessaire
- E. Le risque infectieux est important

5. Les vaccins à ARN :

- A. Utilisent des acides nucléiques
- B. Induisent une réponse immunitaire adaptative
- C. Exposent à un risque infectieux important
- D. Ont un faible coût
- E. Ont une stabilité limitée

6. - La réponse immunitaire induite par les vaccins vivants atténués est à la fois humorale et cellulaire, sauf un : le quel ?

- A. Vaccin anti rougeole
- B. Vaccin anti polio orale
- C. Vaccin anti rubéole
- D. BCG
- E. Vaccin anti varicelle

7. Pour les vaccins vivants atténués :

- A. L'immunité conférée est efficace et durable
- B. Le taux d'anticorps est faible
- C. Les doses de rappel sont indispensables
- D. Le vaccin anti Polio orale nécessite plusieurs doses
- E. Il existe un risque de retour à la virulence

8. Quel(s) est (sont) le(s) vaccin(s) vivant(s) atténué(s) ?

- A. Vaccin BCG
- B. Vaccin anti Haemophilus
- C. Vaccin de la Poliomyélite injectable
- D. Vaccin contre la Rubéole (RR)
- E. Vaccin contre le Pneumocoque

9. Parmi les suivants, quel(s) est (sont) le(s) vaccin(s) sous unitaire(s) ?

- A. Le vaccin anti Polio orale
- B. Le vaccin anti Polio injectable
- C. Le vaccin anti tétanique
- D. Le vaccin anti diphtérique
- E. Le vaccin anti coqueluche acellulaire

Objectif 3 : Décrire la qualité requise d'un bon vaccin

10. L'immunogénicité d'un vaccin dépend de :

- A. La nature du vaccin
- B. L'âge gestationnel de l'enfant
- C. La présence d'un adjuvant
- D. Le nombre des doses
- E. Le poids de l'enfant

11. La nature et l'intensité de la réponse immunitaire d'un vaccin :

- A. Dépendent de la nature de l'antigène
- B. Sont favorisées par l'hydroxyde d'aluminium
- C. Sont meilleurs si le vaccin est administré par voie sous cutanée
- D. Dépendent de la quantité d'antigènes contenus dans le vaccin
- E. S'améliorent avec un nombre réduit des doses administrées

12. Le vaccin est administré :

- A. En intra dermique pour le BCG
- B. En sous cutané pour le vaccin anti Polio vivant atténué
- C. Avant 2 ans, dans la face antéro latérale de la cuisse
- D. Après 2 ans, dans le deltoïde
- E. En intra veineuse

13. Concernant les vaccins, la(les) proposition(s) vraie(s) est (sont) :

- A. Un intervalle minimal de 1 mois entre les doses du même vaccin doit être respectée
- B. La réponse immunitaire dépend de l'âge gestationnel
- C. Les vaccins tués inactivés nécessitent plusieurs injections
- D. La voie d'administration intra musculaire est la plus immunogène
- E. Avant l'âge de 2 ans, l'injection se fait au niveau du deltoïde

Objectif 4 : Citer les effets indésirables des vaccins obligatoires en Tunisie

14. Quel est l'effet secondaire le plus fréquent du vaccin anti tétanique ?

- A. Une fièvre élevée
- B. Une réaction locale œdémateuse et éphémère
- C. Une réaction allergique sévère
- D. Des douleurs musculaires généralisées
- E. Une dyspnée

15. La(es) manifestation(s) secondaire(s) post vaccinale la (es) plus fréquente(s) du vaccin Pentavalent (DTC-Hib-HepB) :

- A. Une encéphalite aigue
- B. Une induration au site de l'injection
- C. Une fièvre dans les 24 heures après la vaccination
- D. Un état de choc
- E. Un syndrome de Guillain Barré

16. Le BCG peut entraîner les manifestations post vaccinales suivantes :

- A. Un état de mal convulsif
- B. Une ulcération locale < 1cm
- C. Une adénite suppurée
- D. Une adénopathie satellite
- E. Une Bécégite généralisée chez l'immunodéprimé

17. Quelles sont les manifestations secondaires possibles après le vaccin anti coqueluche à germe entier ?

- A. Une réaction locale
- B. Une fièvre
- C. Syndrome du cri persistant
- D. Un état de mal convulsif
- E. Une thrombopénie

18. Quelles sont les manifestations post vaccin anti coqueluche à germe entier qui contre indiquent ce vaccin de nouveau ?

- A. Une fièvre survenue le jour de la vaccination
- B. Le syndrome du cri persistant
- C. Une encéphalite aigue
- D. Une réaction douloureuse locale
- E. Un état de choc

19. Les manifestations post vaccinales du vaccin anti rubéole et rougeole (RR) :

- A. Une fièvre entre le 5^{ème} et le 12^{ème} jour post vaccin
- B. Une convulsion
- C. Une leucopénie
- D. Une dyspnée
- E. Une encéphalite

20. Les MAPI à déclarer sont :

- A. Un syndrome de Guillain Barré survenant dans les 8 semaines après la vaccination
- B. Un état de choc
- C. Une réaction locale
- D. Une fièvre apparue le même jour du vaccin
- E. Une paralysie flasque

Objectif 5 : Enumérer les contre-indications des vaccins obligatoires en Tunisie.

21. Les vaccins vivants sont contre-indiqués en cas de :

- A. Maladie cœliaque
- B. Drépanocytose
- C. Déficits immunitaires congénitaux
- D. Grossesse
- E. Asthme allergique

22. Le vaccin anti-Rougeoleux est contre indiqué en cas :

- A. D'immunodépression sévère
- B. D'administration récente d'immunoglobulines
- C. D'infection VIH asymptomatique
- D. De traitement immunosuppresseur en cours
- E. De fièvre légère au moment de la vaccination

Objectif 6 : Décrire le calendrier vaccinal tunisien en vigueur.

23. Quels sont les vaccins réalisés à la naissance selon le calendrier vaccinal national ?

- A. Le vaccin anti Polio injectable
- B. Le vaccin anti Pneumocoque
- C. Le vaccin anti Hépatite B

- D. Le BCG
- E. Le vaccin anti Haemophilus influenzae type b

24. Quel(s) est (sont) le(s) vaccin(s) réalisé(s) à l'âge de 2 mois chez l'enfant en Tunisie ?

- A. Le BCG
- B. Le vaccin anti Pneumocoque
- C. Le vaccin anti Rougeole
- D. Le Pentavalent
- E. Le vaccin anti Hépatite A

25. Le(s) vaccin(s) obligatoire(s) à l'âge de 6 mois, selon le calendrier vaccinal national est (sont) :

- A. Le vaccin Pentavalent
- B. Le vaccin anti Polio injectable
- C. Le vaccin anti Pneumocoque
- D. Le vaccin anti Rougeole et Rubéole
- E. Le vaccin anti Hépatite A

26. Quel est le vaccin obligatoire à l'âge de 4 mois, selon le calendrier vaccinal national ?

- A. Le BCG
- B. Le vaccin anti Pneumocoque
- C. Le vaccin anti Hépatite A
- D. Le vaccin anti Hémophilus influenzae type b
- E. Le vaccin anti Diphtérie

27. Selon le calendrier vaccinal tunisien, quel (s) est (sont) le(s) vaccin(s) effectué(s) à l'âge de 18 mois ?

- A. Vaccin de la Polio orale
- B. Vaccin de l'Hépatite A
- C. Le vaccin de la Rubéole et Rougeole (RR)
- D. Le vaccin anti Pneumocoque
- E. Le vaccin anti Diphtérie-Tétanos-Coqueluche (DTC)

28. Le vaccin anti Pneumocoque utilisé dans le calendrier vaccinal national :

- A. Est administré dès le premier mois de la vie
- B. Est ajouté au calendrier vaccinal national depuis l'année 2000
- C. Se donne en 5 prises selon l'âge de début
- D. Protège contre les infections invasives à pneumocoque
- E. Peut s'administrer avec d'autres vaccins

29. Le vaccin anti Rougeole :

- A. Est un vaccin sous unitaire
- B. Est un vaccin combiné au vaccin anti Polio
- C. Peut être administré dès l'âge de 6 mois en cas d'épidémie
- D. Doit être administré en deux doses pour une protection optimale
- E. Est à éviter en cas d'encéphalopathie anoxo-ischémique

30. La vaccination contre la Rougeole peut être administrée à partir de l'âge de 6 mois, dans les situations suivantes :

- A. En cas de flambée de rougeole dans la région
- B. Avant un voyage dans un pays d'endémie rougeoleuse
- C. En cas de mucoviscidose
- D. Pour tous les enfants en bonne santé, sans autre indication
- E. En cas de cardiopathie congénitale

31. À propos de la réponse immunitaire au vaccin Rougeoleux :

- A. L'efficacité d'une dose unique administrée entre l'âge de 12 et 15 mois est de 85 à 95 %
- B. Une dose précoce (avant 9 mois) protège à vie sans rappel
- C. La 2^e dose permet d'approcher une efficacité de 100 %
- D. Une éruption légère peut survenir entre 6 et 12 jours post-vaccination
- E. Une encéphalite aiguë est fréquente après vaccination

32. Concernant le vaccin anti Poliomyélite :

- A. Le type injectable (VPI) protège contre les trois types de Poliovirus (1, 2, 3)
- B. Le type oral bivalent (VPO) couvre les types 1 et 3
- C. Le type injectable est un vaccin vivant atténué
- D. La paralysie post-vaccinale est fréquente avec le VPI
- E. Le type oral est contre indiqué chez l'immunodéprimé

33. . Concernant la Poliomyélite post-vaccinale :

- A. Elle peut survenir chez le nourrisson vacciné par VPO
- B. Peut se voir dans environ 1 cas sur 7,8 millions de doses de VPO administrées
- C. Le sérotype 2 du VPO est responsable de près de 40% des cas de paralysie post-vaccinale
- D. La paralysie post-vaccinale est fréquente avec le VPI
- E. Est possible dans l'entourage d'un sujet vacciné par le VPO

34. Le vaccin contre l'Hépatite A :

- A. Est un vaccin vivant atténué
- B. Peut être administré dès la naissance
- C. Est contre indiqué en cas de déficit immunitaire
- D. Est indiqué pour prévenir les formes graves et fulminantes
- E. Est intégré dans le calendrier vaccinal à 12 mois et 6 ans

35. Quels sont les vaccins à réaliser en milieu scolaire en 1^{ère} année primaire ?

- A. Le vaccin anti Polio orale
- B. Le vaccin anti Papilloma virus (HPV)
- C. Le vaccin anti hépatite B
- D. Le vaccin anti hépatite A
- E. Le vaccin quadrivalent (DTCaP)

36. Quels sont les vaccins à réaliser chez les filles scolarisées en 6^{ème} année primaire ?

- A. Le vaccin anti Polio orale
- B. Le vaccin anti Papilloma virus (HPV)
- C. Le vaccin anti hépatite B
- D. Le vaccin anti hépatite A
- E. Le vaccin bivalent (dT)

Objectif 7 : Préciser les modalités de surveillance épidémiologique des maladies cibles à la vaccination

37. La stratégie d'éradication mondiale de la Poliomyélite repose sur :

- A. L'interruption totale de la transmission du virus polio sauvage
- B. Le maintien d'une couverture vaccinale élevée
- C. La déclaration dans la semaine de tout cas de paralysie flasque
- D. Deux prélèvements des selles à 24 heures d'intervalle de tout cas de paralysie flasque
- E. Le maintien du vaccin oral au détriment du vaccin injectable

38. Concernant la surveillance épidémiologique des maladies cibles à la vaccination :

- A. Elle repose uniquement sur la confirmation biologique des cas suspects
- B. Toutes les maladies à prévention vaccinale sont des maladies à déclaration obligatoire (MDO)
- C. Chaque cas de paralysie flasque aiguë doit être déclaré dans les 72 heures
- D. Le suivi d'un cas de PFA comprend une visite de contrôle à 60 jours après l'apparition de la paralysie
- E. La déclaration des fièvres éruptives peut être différée après la confirmation biologique

Objectif 8 : Indiquer les vaccins recommandés en fonction des circonstances particulières, et en cas de voyage.

39. Concernant la vaccination du nouveau-né prématuré :

- A. Le vaccin contre l'hépatite B est différée si le poids de naissance est < 2 kg
- B. Le calendrier vaccinal commence à l'âge corrigé de 8 semaines
- C. Le vaccin anti-grippal est recommandé dès l'âge de 6 semaines chez le prématuré
- D. La vaccination débute à partir d'un âge chronologique de 8 semaines
- E. La vaccination de l'entourage contre la grippe et la coqueluche est recommandée

40. Chez un nouveau-né de mère Hbs positive, la sérovaccination après la naissance doit être réalisée :

- A. Dans les 48 heures après la naissance
- B. Dans les 12 à 24 heures après la naissance
- C. À la première semaine de vie
- D. À 6 semaines
- E. À 1 mois de vie

41. Quelle est la dose d'immunoglobulines anti-Hbs à injecter chez le nouveau-né de mère Hbs positive ?

- A. 50 UI en intraveineuse
- B. 100 UI en intramusculaire
- C. 200 UI en sous-cutanée
- D. 100 UI en intraveineuse
- E. 60UI per os

42. Chez un nourrisson de mère Hbs positive, le nombre de doses à recevoir du vaccin anti hépatite B est :

- A. 2 doses
- B. 3 doses
- C. 4 doses
- D. 5 doses
- E. 6 doses

43. Le protocole vaccinal à proposer chez un nouveau-né de mère Hbs positive :

- A. La sérothérapie à la naissance
- B. Le vaccin anti hépatite B à la naissance
- C. Le vaccin Pentavalent à l'âge de 1 mois
- D. Le vaccin Pentavalent à l'âge de 6 semaines
- E. Le vaccin Pentavalent à l'âge de 3 mois

44. Le protocole thérapeutique anti rabique après exposition, est :

- A. Indiqué uniquement si morsure
- B. Débuté si le sujet est symptomatique
- C. Dépendant de l'observation vétérinaire de l'animal mordeur
- D. Administré à J0, J7 et J14
- E. Administré à J3, J7 et J2

Cas clinique N°1:

Nourrisson âgé de 3 mois, est amené par sa mère pour recevoir sa deuxième dose du vaccin pentavalent. Sa maman rapporte qu'après la première injection à 2 mois, le nourrisson a eu une fièvre modérée (38,5°C) avec irritabilité pendant 24 heures, mais tout est rentré dans l'ordre.

1. Parmi les effets les plus fréquents du vaccin anti coqueluche, vous retenez :

- A. Une réaction fébrile durant 24 à 48 heures
- B. Un érythème au site d'injection
- C. Des convulsions au cours du sommeil
- D. Irritabilité
- E. Une paralysie flasque

2. Le vaccin anti coqueluche peut exposer à des réactions graves qui sont :

- A. Une encéphalopathie aigue
- B. L'hypotonie-hyporéactivité
- C. Une éruption bulleuse généralisée
- D. Des troubles du rythme cardiaque
- E. Syndrome du cri persistant

3. Devant une irritabilité avec fièvre post vaccinale, votre conduite consiste à ?

- A. Rassurer les parents
- B. Prescrire le paracétamol
- C. Encourager l'hydratation
- D. Hospitaliser le nourrisson
- E. Interrompre le schéma vaccinal

4. Le vaccin Pentavalent comporte en plus du vaccin contre la coqueluche :

- A. Le vaccin anti l'Hépatite B
- B. Le vaccin contre la Diphtérie
- C. Le vaccin contre le Tétanos
- D. Le vaccin contre l'Haemophilus de type b
- E. Le vaccin contre la Poliomyélite inactivé

5. Malgré vos explications, la mère demeure inquiète et réticente, vous décidez de :

- A. Reporter la vaccination
- B. Prescrire un anti inflammatoire à titre prophylactique

- C. Garder le nourrisson pour surveillance pendant 3 heures après l'injection
- D. Proposer un vaccin anti coqueluche acellulaire
- E. Procéder à la 2^{ème} dose de Pentavalent comme prévu

Cas clinique 2 :

Un nourrisson âgé de 6 mois consulte pour crise convulsive fébrile, apparue 36 heures après la vaccination réalisée au PMI. L'examen clinique ne trouve pas de foyer infectieux.

1. Le(s) vaccin(s) administré(s) à ce nourrisson est (sont):

- A. Anti Rubéole et anti Rougeole (RR)
- B. Anti Pneumococcique
- C. Anti Diphtérie et anti Tétanos (DT)
- D. Le Pentavalent
- E. Anti Polio inactivé

2. Le vaccin responsable de cette convulsion serait l'anti :

- A. Diphtérie
- B. Tétanos
- C. Coqueluche à germe entier
- D. Poliomyélite
- E. Haemophilus b

3. Les vaccins prévus jusqu'à l'âge de 1 an chez ce nourrisson sont :

- A. A 9 mois anti Rougeole
- B. A 11 mois la 3^{ème} dose anti Pneumocoque
- C. A 12 mois l'anti Hépatite B
- D. A 12 mois l'anti Rubéole-Rougeole (RR)
- E. A 12 mois l'anti Hépatite A

Cas clinique N°3 :

Nourrisson âgé de 15 mois, correctement vacciné jusqu'à l'âge de 6 mois. Pour une raison de déménagement, le calendrier a été interrompu.

1. Quels sont les vaccins déjà reçu ?

- A. Le BCG +Hépatite B
- B. 3 doses de Penta + 3 doses de VPO + 2 doses de PCV
- C. 3 doses de Penta + 3 doses de VPI +1 dose de PCV
- D. 3 doses de Penta + 3 doses de VPI + 2 doses de PCV

E. 3 doses de Penta + 3 doses de VPI + 3 doses PCV

2. Quels sont les vaccins non fait ?

- A. Le vaccin anti Pneumocoque
- B. Le vaccin RR (rubéole-rougeole)
- C. Le vaccin anti Hépatite A
- D. Le vaccin anti Méningocoque
- E. Le vaccin anti Polio orale

3. Votre conduite pour rattraper les vaccins manquants, serait de vacciner par :

- A. Vaccin anti Polio orale
- B. Vaccin anti Pneumocoque
- C. Le Pentavalent
- D. Le vaccin RR
- E. Le vaccin anti Hépatite A

Cas clinique N°4 :

Hana, 24 ans, est étudiante en santé et vient consulter pour un **bilan préconceptionnel**. Elle n'a jamais eu la rubéole dans l'enfance. Son carnet de vaccination n'est pas à jour. Elle n'a reçu **aucune dose du vaccin RR (Rougeole-Rubéole)**. Elle demande si elle peut se faire vacciner immédiatement.

1. Le vaccin RR :

- A. Est un vaccin inactivé
- B. Peut se compliquer d'encéphalite
- C. Doit être évité chez la femme enceinte
- D. Est recommandé chez les femmes en âge de procréation non immunisées
- E. Peut être réalisé juste avant la grossesse

2. Le vaccin RR :

- A. Contient deux virus vivants atténués
- B. Est administré à l'âge de 2 mois
- C. Est contre indiqué chez les immunodéprimés
- D. Est administré en 3 prises à 1 mois d'intervalle
- E. Est déconseillé après administration de produits sanguins

3. Que recommandez-vous à Hana ?

- A. La vacciner avec le RR
- B. Lui demander d'éviter toute grossesse pendant le mois suivant
- C. Lui proposer une sérologie rubéole Ig G avant la vaccination
- D. S'assurer qu'elle n'a pas reçu une transfusion dans les jours suivants
- E. L'autoriser à donner son sang immédiatement après la vaccination

Cas clinique N°5:

M. Karim, 45 ans, prépare son pèlerinage à la Mecque prévu dans un mois. Il n'a jamais reçu de vaccin contre la méningite. Il a une HTA bien contrôlée. Il souhaite connaître les vaccins obligatoires et recommandés pour ce voyage.

1. Quels sont les vaccins recommandés ou proposés à M. Karim, avant son départ à la Mecque ?

- B.** Le vaccin quadrivalent anti méningocoque (A, C, W135, Y)
- C.** Le vaccin anti coquelucheux
- D.** Le vaccin anti fièvre jaune
- E.** Le vaccin anti grippe
- F.** Le vaccin anti hépatite B

2. Le vaccin méningococcique quadrivalent, peut se compliquer de :

- A.** Une réaction locale au site d'injection
- B.** Une méningite à méningocoque post-vaccinale
- C.** Une réaction allergique grave (anaphylaxie)
- D.** Une paralysie faciale
- E.** Une fièvre prolongée

3. Le vaccin anti coqueluche chez l'adulte :

- A.** Est obligatoire avant tout voyage
- B.** Est recommandé chez la femme enceinte entre 2^{ème} et 3^{ème} trimestre de grossesse par un vaccin acellulaire
- C.** Peut être administrée en dose unique en cas d'absence de rappel depuis plus de 10 ans
- D.** Est contre-indiquée chez les hypertendus
- E.** Nécessite toujours trois doses espacées d'un mois

4. La vaccination contre l'hépatite B chez les voyageurs :

- A.** Est recommandée uniquement pour les enfants de moins de 15 ans
- B.** Est indiquée pour les adultes non vaccinés prévoyant un séjour > 1 mois dans une zone à endémicité moyenne ou élevée
- C.** Est administrée selon le schéma vaccinal de deux doses à un mois d'intervalle
- D.** Confère une protection immédiatement après la première dose
- E.** Est recommandée chez les voyageurs à comportements particuliers quel que soit la durée du séjour